NỘI DUNG

1. GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ Y TẾ 1
2. MÔ TẢ THỰC TRẠNG THEO KHUNG HỆ THỐNG Y TẾ WHO 1
2.1. Cung ứng dịch vụ (Service delivery) 2
2.2. Nhân lực (Health workforce) 2
2.3. Tài chính (Health financing) 2
2.4. Thuốc, vật tư và trang thiết bị (Medical products & technologies) 3
2.5. Hệ thống thông tin y tế (Health information) 3
2.6. Quản trị và lãnh đạo (Leadership & governance) 3
2.7. Tiếp cận (Access), bao phủ (Coverage), chất lượng (Quality), an toàn (Safety) và đầu ra (Outcomes) 4
3. PHÂN TÍCH SWOT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN 4
3.1. Ma trận SWOT 5
1.1.1 Điểm mạnh (Strengths) 5
2.1.1 Điểm yếu (Weaknesses) 5
3.1.1 Cơ hội (Opportunities) 5
4.1.1 Thách thức (Threats) 5
3.2. Đề xuất giải pháp (gắn SWOT, ưu tiên khả thi trong điều kiện nhân lực mỏng) 5
1.1.1 Nhóm 1 – Chuẩn hóa và "đóng gói" dịch vụ để tăng tiếp cận và bao phủ (S/O, W/O) 6
2.1.1 Nhóm 2 – Thiết lập đầu mối quản lý chương trình và phân công theo năng lực (W/T, W/O) 6
3.1.1 Nhóm 3 – Xây dựng hệ thống thông tin (registry) và KPI tối thiểu (S/O, W/O) 6
4.1.1 Nhóm 4 – Tăng cường truyền thông nội viện và liên kết đầu vào (W/O, S/T) 6
5.1.1 Nhóm 5 – Bảo đảm chất lượng và an toàn khi mở rộng (S/T, W/T) 7
TÀI LIỆU THAM KHẢO 8

1. GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ Y TẾ

Bệnh viện 30-4 trực thuộc Bộ Công an là bệnh viện đa khoa hạng I, giữ vai trò đầu ngành y tế Công an nhân dân (CAND) tại khu vực phía Nam; thực hiện khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ CAND, cán bộ hưu trí, người tham gia BHYT và nhân dân, đồng thời đảm nhiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Về quy mô, bệnh viện có khoảng 500 giường bệnh, 31 khoa/phòng và 01 trung tâm, với hơn 650 nhân sự; trong đó trên 60% có trình độ đại học và sau đại học. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.200–1.400 lượt khám ngoại trú và điều trị 250–350 người bệnh nội trú. Năm 2024, tổng số lượt khám chữa bệnh đạt trên 223.000 lượt, tăng khoảng 13,6% so với năm 2023. Trong bối cảnh BHYT tiến tới bao phủ toàn dân và người dân được quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, nhịp độ hoạt động lớn cùng áp lực cạnh tranh công–tư đặt ra yêu cầu bệnh viện phải không ngừng nâng cao chất lượng và tổ chức lại dịch vụ theo hướng hiệu quả, bền vững.

Trong cơ cấu chuyên môn, **Khoa Sản và Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ)** là đơn vị lâm sàng phụ trách khám, chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh lý sản–phụ khoa. Tuy nhiên, nhân lực bác sĩ tại khoa còn mỏng (khoảng 04 bác sĩ), đồng thời phải phân tán cho nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, làm hạn chế khả năng triển khai các hoạt động dự phòng dài hạn nếu không có mô hình tổ chức phù hợp. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng rõ nét trong lĩnh vực sản phụ khoa, điều này tạo áp lực thu hút người bệnh và đòi hỏi khoa phải đổi mới cách thức tổ chức dịch vụ theo hướng chủ động, dự phòng và chất lượng [1,2].

Dịch vụ Pap nhúng dịch (liquid-based cytology) tại Khoa Sản và KHHGĐ là kỹ thuật sàng lọc quan trọng nhằm phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư cổ tử cung, phù hợp với khuyến cáo của WHO và hướng dẫn chuyên môn trong nước [3,4]. Theo khung hệ thống y tế của WHO, Pap nhúng dịch thuộc cấu phần "cung ứng dịch vụ", song hiệu quả triển khai phụ thuộc đồng thời vào các yếu tố nhân lực, tài chính, trang thiết bị–vật tư, hệ thống thông tin và quản trị [5]. Do đó, việc đánh giá thực trạng theo khung WHO, kết hợp phân tích SWOT và đề xuất giải pháp là cần thiết nhằm chuyển từ mô hình "dịch vụ theo yêu cầu" sang "chương trình sàng lọc định kỳ" có kế hoạch, tăng tiếp cận–bao phủ và bảo đảm chất lượng, an toàn.

2. MÔ TẢ THỰC TRẠNG THEO KHUNG HỆ THỐNG Y TẾ WHO

2.1. Cung ứng dịch vụ (Service delivery)

Tại Khoa Sản và KHHGĐ, xét nghiệm Pap nhúng dịch hiện được triển khai chủ yếu theo nhu cầu tự đăng ký của người bệnh hoặc theo chỉ định của bác sĩ trong quá trình khám phụ khoa. Quy trình kỹ thuật cơ bản gồm: (i) tư vấn trước xét nghiệm; (ii) lấy mẫu tế bào cổ tử cung bằng chổi chuyên dụng; (iii) nhúng mẫu vào dung dịch bảo quản; (iv) chuyển mẫu đến Khoa Giải phẫu bệnh để xử lý, nhuộm và đọc kết quả theo hệ thống Bethesda; (v) trả kết quả và tư vấn sau xét nghiệm. Thời gian trả kết quả trung bình khoảng 03 ngày. Theo theo dõi thực hành tại khoa, chưa ghi nhận tai biến hoặc biến chứng liên quan đến thao tác lấy mẫu.

Về quy mô, số lượng Pap nhúng dịch trung bình khoảng 03 ca/ngày, ước tính 1.000–1.200 ca/năm (số liệu nội bộ khoa/ghi nhận thực hành). So với tiềm năng nhóm phụ nữ đến khám và nhóm nguy cơ trong cộng đồng, quy mô này còn khiêm tốn.

Nhận định quản lý: hoạt động Pap nhúng dịch hiện mới dừng ở mức "cung ứng kỹ thuật theo yêu cầu", chưa được tổ chức thành chương trình sàng lọc định kỳ có kế hoạch. Do đó, khả năng tăng bao phủ và quản lý theo dõi sau xét nghiệm (nhắc lịch, gọi lại trường hợp bất thường, bảo đảm quay lại) còn hạn chế.

2.2. Nhân lực (Health workforce)

Khoa Sản và KHHGĐ hiện có khoảng 04 bác sĩ sản phụ khoa cùng đội ngũ nữ hộ sinh và điều dưỡng hỗ trợ. Về chuyên môn, nhân viên thực hiện lấy mẫu và tư vấn cơ bản đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp với Khoa Giải phẫu bệnh giúp bảo đảm luồng xét nghiệm và trả kết quả tương đối ổn định.

Tuy nhiên, do nhân lực bác sĩ mỏng và phải đảm nhiệm đồng thời nhiều nhiệm vụ (khám thường quy, trực cấp cứu, tham gia đào tạo, nghỉ chế độ…), thời gian dành cho các hoạt động đặc thù của chương trình sàng lọc như truyền thông chủ động, lập danh sách đối tượng mục tiêu, nhắc lịch định kỳ, gọi lại trường hợp bất thường và tổng hợp báo cáo giám sát còn hạn chế.

Nhận định quản lý: nếu không có đầu mối phụ trách (focal point) và phân công thời gian rõ ràng, sàng lọc sẽ khó chuyển từ "dịch vụ theo yêu cầu" sang "chương trình định kỳ", bởi bản chất chương trình đòi hỏi quản lý liên tục, không chỉ là thao tác kỹ thuật.

2.3. Tài chính (Health financing)

Hiện nay, Pap nhúng dịch chủ yếu phát sinh theo nhu cầu tự đăng ký của người bệnh, chưa được tích hợp thành các gói khám sức khỏe phụ nữ hoặc khám định kỳ. Vì vậy, sản lượng phụ thuộc nhiều vào "dòng bệnh" và thói quen người bệnh, khiến khoa khó chủ động dự trù vật tư và kế hoạch triển khai theo đợt.

Trong bối cảnh cạnh tranh từ khu vực tư nhân, nếu không có thiết kế tài chính phù hợp (giá dịch vụ, gói khám, truyền thông và ưu đãi theo nhóm đối tượng), khả năng mở rộng tiếp cận sẽ bị hạn chế. Ngược lại, việc tăng sản lượng khi chưa có dự toán vật tư–nhân lực–xét nghiệm tương ứng có thể dẫn tới quá tải và giảm chất lượng.

Nhận định quản lý: cần xác lập mô hình tài chính theo hướng "đóng gói dịch vụ" (gói khám sức khỏe phụ nữ, gói sàng lọc định kỳ), gắn phân bổ nguồn lực với sản lượng và đi kèm cơ chế giám sát chất lượng để mở rộng bền vững.

2.4. Thuốc, vật tư và trang thiết bị (Medical products & technologies)

Bệnh viện có nền tảng xét nghiệm và Khoa Giải phẫu bệnh tiếp nhận xử lý mẫu, đây là lợi thế giúp Pap nhúng dịch vận hành tương đối ổn định. Tuy nhiên, chất lượng và tính liên tục của dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào vật tư tiêu hao (chổi lấy mẫu, lọ dung dịch bảo quản, lam kính, hóa chất nhuộm) và quy trình vận chuyển, bảo quản mẫu.

Khi mở rộng chương trình, nhu cầu vật tư tăng theo sản lượng; nếu không chuẩn hóa định mức tồn kho tối thiểu và kiểm soát chất lượng mẫu, nguy cơ tăng tỷ lệ mẫu không đạt hoặc kéo dài thời gian trả kết quả có thể xảy ra.

Nhận định quản lý: cần chuẩn hóa "đường đi của mẫu" (lấy mẫu – ghi nhãn – vận chuyển – tiếp nhận – đọc – trả kết quả) bằng checklist và theo dõi các chỉ số chất lượng như tỷ lệ mẫu không đạt và tỷ lệ trả kết quả đúng hẹn.

2.5. Hệ thống thông tin y tế (Health information)

Hiện chưa có hệ thống dữ liệu sàng lọc (registry) để quản lý danh sách đối tượng, lịch sàng lọc, kết quả và theo dõi tái khám. Các chỉ số quan trọng của chương trình như tỷ lệ người bệnh nhận kết quả, tỷ lệ được tư vấn sau xét nghiệm, tỷ lệ chuyển tuyến hoặc soi cổ tử cung khi bất thường chưa được theo dõi một cách hệ thống, làm hạn chế khả năng đánh giá hiệu quả và cải tiến chất lượng.

Nhận định quản lý: trong bối cảnh bệnh viện đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đây là cơ hội để tích hợp Pap nhúng dịch vào HIS/EMR, xây dựng registry sàng lọc, cơ chế nhắc lịch (SMS/Zalo/điện thoại) và dashboard theo dõi chỉ số.

2.6. Quản trị và lãnh đạo (Leadership & governance)

Hoạt động Pap nhúng dịch hiện chưa được ban hành thành một "chương trình sàng lọc định kỳ" với mục tiêu, chỉ tiêu, quy định tuyến chuyển, phân công trách nhiệm và cơ chế giám sát, báo cáo cụ thể. Công tác quản lý hiện vẫn thiên về hoạt động khám chữa bệnh thường quy, trong khi sàng lọc đòi hỏi cách tiếp cận quản lý dự phòng, liên tục và phối hợp liên khoa.

Nhận định quản lý: để chuyển đổi mô hình, cần ban hành kế hoạch hoặc đề án chính thức ở cấp khoa hoặc bệnh viện, quy định rõ "ai làm gì, khi nào, chỉ tiêu gì và giám sát ra sao".

2.7. Tiếp cận (Access), bao phủ (Coverage), chất lượng (Quality), an toàn (Safety) và đầu ra (Outcomes)

Tiếp cận: người bệnh có BHYT và quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh; tuy nhiên Khoa Sản và KHHGĐ chịu bất lợi do cạnh tranh từ khu vực tư nhân, trong khi truyền thông nội viện về sàng lọc chưa mạnh và Pap chưa được tích hợp vào gói khám định kỳ.

Bao phủ: ước tính chỉ khoảng 20–30% phụ nữ đến khám được thực hiện sàng lọc (bằng chứng: ghi nhận thực hành/ước tính khoa), chưa tiếp cận hiệu quả nhóm phụ nữ không khám thường xuyên.

Chất lượng: thao tác kỹ thuật ổn định, thời gian trả kết quả tương đối nhanh (khoảng 03 ngày); tuy nhiên chưa thiết lập hệ thống KPI chất lượng xét nghiệm và chương trình (tỷ lệ mẫu không đạt, tỷ lệ trả kết quả đúng hẹn, tỷ lệ theo dõi sau bất thường).

An toàn: chưa ghi nhận tai biến lấy mẫu; cần tiếp tục duy trì kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo mật thông tin và tư vấn giảm lo âu cho người bệnh.

Đầu ra: hiện chủ yếu mới đo lường "số ca làm Pap", chưa đo các đầu ra của chương trình như tỷ lệ nhận kết quả, tỷ lệ theo dõi tiếp và tỷ lệ bất thường được quản lý đúng quy trình.

Tổng hợp nhận định: Khoa Sản và KHHGĐ có nền tảng kỹ thuật và phối hợp xét nghiệm tốt, nhưng còn thiếu các yếu tố về quản trị, hệ thống thông tin và tổ chức để hình thành chương trình sàng lọc định kỳ. Các nút thắt chính gồm nhân lực mỏng, thiếu đầu mối quản lý chương trình, thiếu registry sàng lọc và chưa đóng gói dịch vụ nhằm tăng tiếp cận và bao phủ.

3. PHÂN TÍCH SWOT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN

3.1. Ma trận SWOT

1.1.1 Điểm mạnh (Strengths)

Bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Công an, có uy tín và thương hiệu, tạo được niềm tin đối với người bệnh.Đã triển khai kỹ thuật Pap nhúng dịch với quy trình cơ bản chuẩn hóa, bảo đảm an toàn, chưa ghi nhận tai biến.Có sự phối hợp với Khoa Giải phẫu bệnh, thời gian trả kết quả tương đối ổn định (khoảng 03 ngày).Hệ thống tiếp nhận khám bệnh và đăng ký dịch vụ sẵn có, thuận lợi cho việc tổ chức triển khai dịch vụ.

2.1.1 Điểm yếu (Weaknesses)

Hoạt động Pap nhúng dịch còn mang tính thụ động, chưa được tổ chức thành chương trình sàng lọc định kỳ.Nhân lực bác sĩ tại Khoa Sản và KHHGĐ còn mỏng (khoảng 04 bác sĩ), khó bố trí thời gian cho công tác quản lý chương trình.Chưa có cán bộ đầu mối hoặc bộ phận chuyên trách; thiếu cơ chế theo dõi, nhắc lịch và gọi lại người bệnh.Truyền thông nội viện về sàng lọc ung thư cổ tử cung còn hạn chế; Pap nhúng dịch chưa được tích hợp vào gói khám sức khỏe phụ nữ.Chưa xây dựng hệ thống dữ liệu sàng lọc (registry) và các chỉ số KPI theo dõi chất lượng và đầu ra chương trình.

3.1.1 Cơ hội (Opportunities)

BHYT bao phủ toàn dân và quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế dự phòng [1].Khuyến cáo của WHO và hướng dẫn của Bộ Y tế ngày càng nhấn mạnh vai trò sàng lọc ung thư cổ tử cung [3,4].Nhu cầu chăm sóc sức khỏe phụ nữ ngày càng tăng, người dân quan tâm nhiều hơn đến sàng lọc sớm.Xu hướng chuyển đổi số y tế tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý dữ liệu, nhắc lịch và theo dõi kết quả.Định hướng phát triển bệnh viện theo hướng nâng cao chất lượng và dịch vụ kỹ thuật cao là nền tảng để chuẩn hóa và quảng bá hoạt động sàng lọc.

4.1.1 Thách thức (Threats)

Cạnh tranh mạnh mẽ từ các bệnh viện tư nhân và phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa với dịch vụ nhanh và linh hoạt.Thói quen người dân ưu tiên cơ sở thuận tiện về thời gian, quy trình và truyền thông.Nếu mở rộng sàng lọc mà không đi kèm bổ sung nguồn lực, nguy cơ quá tải, giảm chất lượng và kéo dài thời gian trả kết quả.Rủi ro đứt gãy theo dõi sau xét nghiệm nếu không có hệ thống gọi lại và điều phối hiệu quả.

3.2. Đề xuất giải pháp (gắn SWOT, ưu tiên khả thi trong điều kiện nhân lực mỏng)

1.1.1 Nhóm 1 – Chuẩn hóa và "đóng gói" dịch vụ để tăng tiếp cận và bao phủ (S/O, W/O)

Ban hành "Quy trình sàng lọc định kỳ ung thư cổ tử cung bằng Pap nhúng dịch" ở cấp khoa hoặc bệnh viện, quy định rõ chỉ định, chống chỉ định, quy trình lấy mẫu, luồng chuyển mẫu, thời gian trả kết quả, tư vấn sau xét nghiệm và hướng xử trí khi có kết quả bất thường theo hướng dẫn chuyên môn [3,4].Tích hợp Pap nhúng dịch vào các gói khám sức khỏe phụ nữ và khám định kỳ (gói phụ khoa cơ bản, gói sàng lọc cổ tử cung, gói khám tiền hôn nhân…), qua đó chuẩn hóa tư vấn, tăng tỷ lệ được đề nghị sàng lọc và chủ động kế hoạch vật tư, nhân lực.Thiết kế "đường đi người bệnh" gọn nhẹ (đăng ký → khám/tư vấn → lấy mẫu → hẹn trả kết quả/nhắc lịch), ưu tiên giảm thời gian chờ cho nhóm sàng lọc nhằm cải thiện trải nghiệm dịch vụ trong khuôn khổ nguồn lực hiện có.

2.1.1 Nhóm 2 – Thiết lập đầu mối quản lý chương trình và phân công theo năng lực (W/T, W/O)

Phân công 01 cán bộ đầu mối (có thể là nữ hộ sinh hoặc điều dưỡng được đào tạo) phụ trách quản lý registry, nhắc lịch, tổng hợp báo cáo và phối hợp liên khoa; bác sĩ tập trung vào tư vấn chuyên môn, xử trí các trường hợp bất thường và quyết định lâm sàng.Tổ chức sàng lọc theo đợt hoặc theo khung giờ cố định trong tuần (ví dụ 1–2 buổi/tuần) để phù hợp với nguồn nhân lực, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh thường quy.

3.1.1 Nhóm 3 – Xây dựng hệ thống thông tin (registry) và KPI tối thiểu (S/O, W/O)

Tận dụng hệ thống HIS/EMR để thiết lập các trường dữ liệu bắt buộc cho Pap nhúng dịch (ngày lấy mẫu, kết quả Bethesda, ngày trả kết quả, khuyến cáo theo dõi).Xây dựng danh sách đối tượng sàng lọc và cơ chế nhắc lịch tái sàng lọc bằng SMS/Zalo/điện thoại.Theo dõi tối thiểu 6 chỉ số: (1) số ca Pap/tháng; (2) tỷ lệ trả kết quả đúng hẹn; (3) tỷ lệ mẫu không đạt; (4) tỷ lệ phát hiện bất thường; (5) tỷ lệ người bệnh nhận kết quả; (6) tỷ lệ được theo dõi hoặc khám tiếp khi có bất thường. Các chỉ số này phản ánh cả chất lượng xét nghiệm và đầu ra chương trình, phục vụ cải tiến liên tục [2].

4.1.1 Nhóm 4 – Tăng cường truyền thông nội viện và liên kết đầu vào (W/O, S/T)

Đẩy mạnh truyền thông tại các điểm tiếp xúc như Khoa Khám bệnh và phòng khám phụ khoa bằng poster, tờ rơi và tư vấn ngắn theo kịch bản chuẩn (lợi ích – tần suất – quy trình – hẹn trả kết quả).Lồng ghép Pap nhúng dịch vào các chương trình khám sức khỏe định kỳ của đơn vị trong ngành, xây dựng gói "khám sức khỏe phụ nữ + Pap" nhằm tạo

nguồn người bệnh ổn định.Tăng sức cạnh tranh thông qua chất lượng và trải nghiệm dịch vụ, cam kết thời gian trả kết quả và tư vấn rõ ràng.

5.1.1 Nhóm 5 – Bảo đảm chất lượng và an toàn khi mở rộng (S/T, W/T)

Áp dụng checklist lấy mẫu – ghi nhãn – vận chuyển – tiếp nhận; đào tạo định kỳ cho nhân viên mới và giám sát tỷ lệ mẫu không đạt.Rà soát quy trình phối hợp với Khoa Giải phẫu bệnh để duy trì thời gian trả kết quả khoảng 03 ngày khi sản lượng tăng, kèm kế hoạch dự phòng vật tư và nhân lực.Bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo mật thông tin và tư vấn giảm lo âu, giúp người bệnh hiểu rõ bước tiếp theo khi có kết quả bất thường, tránh bỏ sót theo dõi.

Kỳ vọng tác động: Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp trên, hoạt động Pap nhúng dịch sẽ chuyển từ "dịch vụ theo yêu cầu" sang "chương trình sàng lọc định kỳ" có đầu mối quản lý, dữ liệu theo dõi và hệ thống chỉ số chất lượng rõ ràng. Qua đó, chương trình góp phần tăng khả năng tiếp cận và độ bao phủ sàng lọc, phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung, giảm gánh nặng điều trị về sau và nâng cao hiệu quả y tế dự phòng. Đồng thời, việc chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng góp phần cải thiện hình ảnh, uy tín và sức cạnh tranh của bệnh viện trong bối cảnh bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân và người dân được quyền lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh.

Trong bối cảnh hiện nay, Bệnh viện 30-4 đang từng bước chuyển mình với nhiều cơ hội phát triển và cạnh tranh thuận lợi. Bệnh viện có điều kiện tăng cường liên kết chuyên môn với các bệnh viện lớn và cơ sở y tế đầu ngành như các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối trong khu vực, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa quy trình và tiếp cận các mô hình quản lý, kỹ thuật tiên tiến. Bên cạnh đó, vai trò là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên y khoa của các trường đại học lớn trong khu vực giúp bệnh viện không chỉ góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng, mà còn tạo môi trường thuận lợi để triển khai, đánh giá và cải tiến các mô hình chăm sóc sức khỏe dự phòng dựa trên thực hành thực tế.

Việc phát triển chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng Pap nhúng dịch trong bối cảnh này không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và nhân dân, mà còn phù hợp với định hướng phát triển bền vững của bệnh viện, gắn kết giữa nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo và phục vụ cộng đồng. Qua đó, Bệnh viện 30-4 có thể tận dụng hiệu quả các cơ hội hợp tác, đào tạo và cạnh

tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống y tế hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Báo cáo tổng kết thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 2021.

2. Bộ Y tế. Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Nhà xuất bản Y học; 2018.

3. Bộ Y tế. Hướng dẫn sàng lọc, chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung thư. Nhà xuất bản Y học; 2020.

4. World Health Organization. Comprehensive Cervical Cancer Control: A Guide to Essential Practice. 2nd a.b. World Health Organization; 2014.

5. World Health Organization. Monitoring the Building Blocks of Health Systems. World Health Organization; 2010.